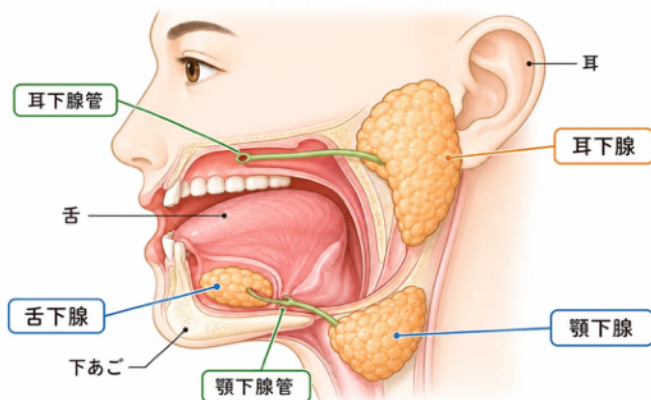
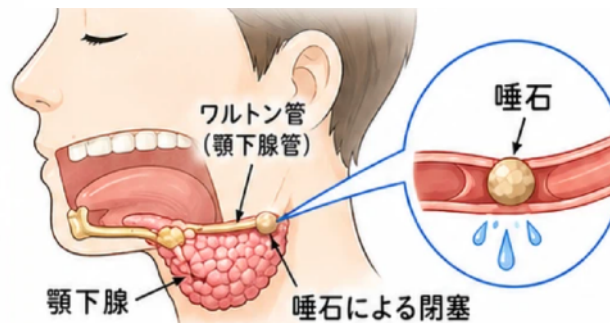


唾石を摘出する手術：口の中から？首の外から？

●…… 唾液腺の解剖 ……●

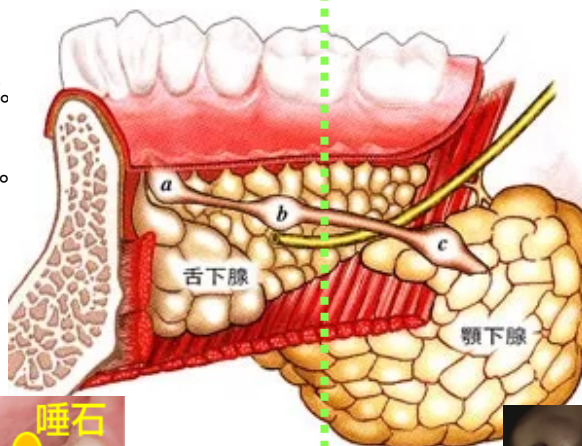


- 耳下腺管は上の奥歯の頬側の粘膜(頬粘膜)に開口します。
- 顎下腺管は舌の裏側の小帯の両脇(舌下小丘)に開口します。



- 唾液の通り道に石ができる
- 特に顎下腺に多い
- 唾液が流れにくくなるため腫れや痛みが起こる

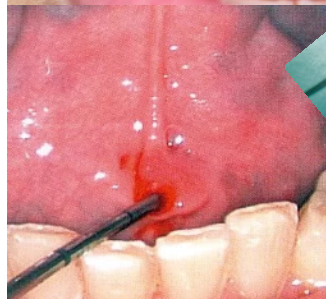
① 手前にある小さい唾石(a-b)は、口の中から細い内視鏡で摘出します。唾石の大きさ4mm以下に限ります。引っかかって取れない時もあります。



② 奥にある大きい唾石(c)は、首を切って顎下腺ごと摘出します。傷は半年後には目立たなくなりますが、口唇麻痺の合併症があります。顎下腺もなくなるので、二度と唾石はできません。内視鏡手術よりも短時間(1時間)で、術後の腫れと痛みも少ないです。

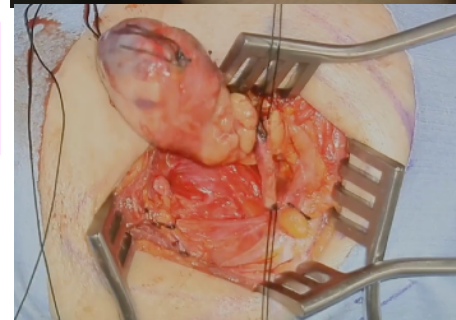


超音波検査とCT画像で、唾石の場所と大きさを調べます。検査の結果で、①内視鏡か②外切開か手術方法を決めます。



傷が気になる若い女性には、①内視鏡手術を考えます。傷が気にならない年齢、男性には、確実に治る②外切開をおすすめします。

口の中から内視鏡手術を選んだ場合、残念ながら取れないこと(失敗)もあります。次の手を決めておきます。
(1) その日の手術は中止して撤退する、唾石は残る。
(2) 外切開に切り替えて、傷が残るのはあきらめる。
どちらにするか手術の前に決めておく必要があります。



	唾石の大きさと場所	長所	短所
① 口腔内から内視鏡	4mm以下が望ましい 出口近くの浅い場所	皮膚を切らずに傷が残らない	口から取れない時もある 術後に口の中が腫れる 舌のしびれ味覚低下の合併症
② 皮膚を切って外切開	小さくても大きくても可能 顎下腺近くの深い場所	失敗なく確実に取れる 顎下腺がないので再発しない	皮膚に傷が残る 口唇が麻痺する合併症